

* Poussée Hypertensive :

PAS ≥ 180 mmHg et/ou PAD ≥ 110 mmHg
Classification : But = 140/90 mmHg

* HTA sévère : $\uparrow$ TA sans souffrance viscérale
 $\Rightarrow$ Trt Ambulatoire

* Urgence Hypertensive : $\uparrow$ TA avec souffrance
 $\Rightarrow$ (H)

- Rassurer le patient
- Prise de TA
- O₂ thérapie 3-4 l/min
- Voie d'abord
- Rechercher l'étiologie si : stress...

+ 0.1 Amp pimplexan en IM 30 min
si : TA normale $\Rightarrow$ Bilan HTA.

* Bilan : FNS / glycémie à jeun / Urée / Créat
CT / HDL-c / LDL-c / TG / Uricémie / CU

ionogramme sanguin

* si : TA après 30 min pas d' (A) :

$\Rightarrow$ Captopril 1 cp 25 ou 1 cp en ~~sublingual~~
après 0.5 h pas d' (A) : en per os !
 $\Rightarrow$ 2ème cp

- * R après 01h pas d'①A ⇒ 2^{ème} cp
- après 01h pas d'①A : (cp inefficace)
- ⇒ Loxen inj 01cc diluée en 3cc SG 5% IV0
- après 30min pas d'①A : 02cc puis 03 ... 10cc

Ordonnance :

11 - Amlor 5mg _____ 01 hte

01cp 1j à heure fixe

+ Bilan d'HTA + Régime 1/2 sale

⇒ Avis Cardio!

+ Profil TA 3x1j pdt une semaine

* Clinique :

⇒ Céphalée / vertiges / Acouphènes / épistaxis

* éliminer une urgence hypertensive :

* AVC ⇒ signes neuro de localisation

* Dissection Aortique ⇒ Douleur rétro
sternale en coup de poignard migratrice
irradiant vers le dos, souffle Aortique

* OAP ⇒ dyspnée + ~~rales~~ crépitaux

* IDM ⇒ douleur thorax constrictrice irradiant
vers l'épaule gauche + signes ECG

* Rétinopathies hypertensives, pré-éclampsie

* AVC *

* clinique: Troubles neurologiques

⇒ Aphasie ou Dysarthrie, Céphalée, Flou visuel
Paralysie faciale centrale ou périphérique
Déficit moteur: Hémiparésie ou Hémiplogie
Dg ≠ = perte des urines ou morsure de la langue ⇒ crise épileptique

Note: TA > 18/10 ne pas ↓ TA avant TDM.
sauf si TA = 220/120 on ↓

. CAT: * 2^e thérape / Vire d'abord / TA / T°
Dextro. + ECG pour éliminer IDM

⇒ Evacuation pour faire une TDM Cérébrale

* Scanner:

20% Hyperdensité: AVC hémorragique
80% Hypodensité: AVC ischémique
→ Evaluation Neurochir
→ (+) ou (-) 24 à 48h.

Scanner normal ⇒ suspicion d'AVC ischémique
à refaire 48-72h après.

⇒ Mannitol 100cc / 8h

⇒ SGI est CI ⇒ risque d'œdème cérébral

- * Metelas antireuxures
- * O₂ thérapie 0.3 l/min sauf si SaO₂ est normale
- * Réhydratation SSI 18 h 0.1 glucan
- si = $T \uparrow$ 0.1 glucan de perfalgan 108 h
- si = glycémie
- ⊕ 2g $\Rightarrow$ insulinothérapie
- 10 UI IO en sous cutané / h
- Ⓜ 24 h $\rightarrow$ 48 h pas d'alimentation orale
- après 2 j alimentation orale si pas
- $\Rightarrow$ sonde gastrique + vésiculaire

Ordonnance :

Somazina Amp 500 mg en IVL
 250 cc SSI 140 gtt / min
 0.1 Amp / 24 h

Bilan :

- $\Rightarrow$ FNS / glycémie à jeun / urée / créat / CT / TG
- ionogramme sanguin
- * si = Hypo Na⁺ $\Rightarrow$ NaCl 3g / j = 1g / flacon
- Hypo K⁺ $\Rightarrow$ KCl 2g

* Si = Risque d'infection nosocomiale "Préventif"
Cefotaxime $\Rightarrow$ Claforan 1g/12h 2x1j
ou Augmentin 1g/12h.

* Si = TA > 230/120.

$\Rightarrow$ 01 cc Loxen dilué SG 5%

* ECG = TDR $\Rightarrow$ Avis Cardio / Med interne

• 03 Lettres =

* Consultation Cardio!

* Consultation Neuro!

* Consultation Kinésithérapie!

01 mois $\Rightarrow$ Mvt passifs

01 mois $\Rightarrow$ Mvt Actifs

* QAP :

* Clinique : Dyspnée, détresse resp, Cyanose, difficulté de parler, Hypotension $++$, Raïles crépitants $++$, Toux sèche, glaire blanchâtre, sueurs, fièvre presque crise d'asthme mais pas d'HTA d'asthme même en présence de raïles sibilants $\oplus$ 50 ans HTA / Cardiopath

8-10l
* O₂ thérapie / Dextro / TA / T° / Voie d'abord
 $\Rightarrow$ position $1/2$ assise, pieds pendante.

* δ : TA > 110 mmHg
 $\Rightarrow$ Lasix 40 mg en IVD chaque 20 min

* Bilan : FVS / glycémie / Urée / Créat si IR $\nearrow$
Lasix 120 mg / ionogramme / CRP

* TLT de force $\Rightarrow$ Confirme le dg

* ECG $\Rightarrow$ IDM

• 250 mg Aspirine
 • 0.1cp plavix
 • 0.14 Tenormin en SC

} Thrombolyse

20 - 30 min $\delta = TA$ est $T_j > 110 \text{ mmHg}$
 $\Rightarrow$ Lasix 40 mg en IVD
ou Léntrol 1 mg en IVD
ou Risoran 2 mg en IVD

* $\delta =$ Non reprise $\Rightarrow$ Avis δ !

$TA < 110 \text{ mmHg} :$

$\Rightarrow$ O₂ théra δ pré os-10l.
Voie d'abord

SG 5%

$\Rightarrow$ Avis δ : Dobutrex 5 $\mu\text{g/kg/min}$



* IMM :

* Clinique : Douleur constrictrice / Brûlure irradiée vers la mâchoire inférieure au poignet / épaule gauche pâle / cyanosé / sueurs !
⇒ O₂ / Thérapie / TA / dextro / voie d'abord

⇒ H L₂ Si SaO₂ < 90%

⇒ Bilan : FNS / TP / glycémie / Urée / Créat / ionog

⇒ ECG : 5 min 9e fois 10 min.

Sur décalage > 2 mm d'au - 2 D
ds 2 ECG de 20 min d'intervalle

⇒ Soulager la douleur : 01 flacon de parafalgan
voir un dérivé morphinique si la douleur est intense

⇒ Chlorhydrate de morphine 5mg inj
1/2 Amp en s/c ou IV.

Ordonnance :

- 1) - Aspirine 300 ou 250mg en IV puis
+ 1 sac 100mg/lj
 - 2) - Plavix 75mg (ou ip) en 1 seule prise puis
 - 3) - Xovenox 4000 UI ——— 1 c p lj
100 UI / Kg en s/c 2x 1j
- 0,3 CC en IV D (8) ⇒ Evacuation en 2 Carctio!

* Loma :

- ⇒ Position latérale de sécurité "PLS"
- ⇒ 2^e thérape / Dextro / TA / T° / Vœ d'abord perfusion SST
- ⇒ Bilan : FNS / glycémie / Urée / Créat / CPK ASAT / ALAT / ionogramme sanguin
- ⇒ ECG

Si : Trauma
 Crâne
 Si = pas Trauma

signes de focalité ⇒ Avis Neuro!
pas signes de focalité ⇒ Scanner

- CO ⇒ O₂ 8l / min
- médicaments ⇒ O₂ + 100mg HHC en IV
- Hypoglycémie ⇒ 50cc SG 30% puis perfusion 01 flacon SG 10%
01 flacon SG 5%

01 flacon 18h

resuscitation de conscience ⇒ Alimentation (glucide / lipide) pour éviter le Rckn

* coma hypoglycémiques

* clinique : Trouble de conscience ou neuro
⇒ glycémie veineuse $< 0.5 \text{ g/l}$ ou $< 2.8 \text{ mmol/l}$
(asthénie, tremblet, sueurs, faim,
Tachycardie, céphalée, vertiges, acouphènes
Trouble visuels, déficit moteur

⇒ O₂ thérape IVe d'abord | Dextro | TA

* Si = patient conscient

• Administration en urgence de boissons sucrée

* Si = patient inconscient

⇒ 50 cc SG 30% en IVD

⇒ 50 cc SG 10% en 1h

Relais ⇒ 01 flacon SG 5% / 8h

chez le diabétique risque de rechute
ou si voie d'abord difficile (coma agité)

⇒ 1-2 mg 01 Amp de glucagone en I/M ou SC
20 min Si = glycémie T_j^- ↓ 2^{ème} Amp

Glucagon CI : Alcoolisme / S / sulfamide hypogly

* Si = insuffisance ^{sur} rénale aigue : ISA

⇒ 200 mg HHC en IVD

* Hyperglycémie Sans Cétose :

- Sujet diabétique : mauvaise prise de Trt au infect
- Sujet non diabétique : Vertiges, adhérence, fécès

PDF : * Dextro $> 2.5 \text{ g/l}$ * Labstix : CC (-)

$\Rightarrow$ Insuline IO : 100U en SC / h.

+ Réhydratation : Boire 1.5l d'eau + perfusion SSI ... 6 flacons (1.5l d'is2h)

$\Rightarrow$ TLT : rechercher infections pulmonaires

$\Rightarrow$ Labstix : infection urinaire $\Rightarrow$ ECBU.

$\Rightarrow$ ECG : rechercher Hypok⁺ si (+) à corriger avant l'insulinothérapie.

$\Rightarrow$ Surveillance de glycémie capillaire / 30 min

si : FDR + Découverte gly $\uparrow \Rightarrow$ (H)

si : CC (+) + gly $\uparrow \Rightarrow$ (H)

* Après 01h :

! si : CC (-) + gly $< 2 \text{ g/l}$ $\Rightarrow$ Libérer avec un Trt biologique si infect

si : CC (-) + gly $> 2 \text{ g/l}$ $\Rightarrow$ Continuer même schéma d'insulinothérapie jusqu'à l'obtention de l'objectif de Trt

- Si CC (+) + gly $> 2 \text{ g/l}$ $\Rightarrow$ Continuer même schéma sans insuline à la seringue élective
- Si Patient instable appel Pa Réa !
 $\Rightarrow$ Avis Réa !
- $\Rightarrow$ Ne libérer jamais le patient sans $(-)$ du CC.
- PDF: Ucé / Créat / ionogr — e .

* Acidocétose Diabétique :

Gly $\uparrow$ 2g/l + gluco / cétonurie
(++) (++)

* Clinique :

- Hyperglycémie $\Rightarrow$ Fatigue, polyurie, dyspnée
soif intense, Boire +++
- Hypercétonurie $\Rightarrow$ Douleur Abd, odeur
acétonurique de l'haleine, $\uparrow$ conscience
- Acidose $\Rightarrow$ Respiration de Kussmaul, HypoPA
- Déshydratation

* MU : O_2 thérapie / TA / T° / Dexbro / Labetix / PLS
cyps cétoniques = +++ $\leftarrow$

+ ICG + TLT (foyer)

* Bilan : FAS / glycémie V / CRP / Urée / Créat
ionogramme sanguin / ECBU

Trt : Réhydratation + Insulinothérapie

* Réhydratation :

- 1l en 1h ou 1h $\Rightarrow$ 1l SSI (ou Flacons 5%) chaque 1/2h
1l en 2h ou 2h $\Rightarrow$ 1l SSI " 1h
1l en 3h ou 3h $\Rightarrow$ 1l SSI " 1h30
1l chaque 4h 4h $\Rightarrow$ 1l SSI " 2h
• 0 - 2h $\Rightarrow$ SSI (2l) + 1.5g/l KCl qq K+

ECG = IDM / signes HyperK⁺ (onde T pointue /
QRS élargie / PR > 0,2s chaque 2h
Si: K > 6,5 mm $\Rightarrow$ Avis Réa!

- 2-6h: SG 5% (2L) Si gly < 3g $\rightarrow$ 1,5g
+ 2g NaCl (0,5 ds chaque flacon)

Si: ionogramme NL + 1,5g KCl

- 6-24h: SG 5% (2L)
+ 2g NaCl + 1,5g KCl dépend ionog

Si: Fièvre $\Rightarrow$ Parfalgan 18h

infec $\Rightarrow$ Claforan 2x1j / 12h

* Insulinothérapie = IV jusqu'à 24h / cc =
50cc SST + 0,1 UI/kg/h

Si: pas cc $\Rightarrow$ Parse sc / 1h.
10UI IO en sc / h

Glycémie 2h $\rightarrow$ SST SG 5%
après 2h $\rightarrow$ SG 10%

Gly > 2,5 $\Rightarrow$ SG 9%
1,5 < Gly < 2,5 $\Rightarrow$ SG 5%
Gly < 1,5 $\Rightarrow$ SG 10%

Tonogramme
chaque 2h

$X \leq 3 \text{ mmol/l} \Rightarrow \text{KCl } 2 \text{ g/l ds } 2 \text{ h.}$
 $3 < X < 4 \text{ mmol/l} \Rightarrow \text{KCl } 1,5 \text{ g/l}$
 $X > 4 \text{ mmol/l} \Rightarrow \text{KCl } 0,5 \text{ g/l}$
 $5,5 \text{ mmol/l} \Rightarrow \text{Pas.}$
 $6,5 - 7 \text{ mmol/l} + \text{Anomalies d'ECG} \Rightarrow \text{Rea!}$

1er inf $\Rightarrow 15 \text{ UI par ex } 15\% \times 2 = 8.$

$\nabla 0,8 \text{ UI } 10 \text{ en IVD}$

$0,7 \text{ UI } 10 \text{ en IM pas SC } S = CC \oplus$

ou $100 \text{ UI } 1 \text{ h en IVD} + \text{KCl} \rightarrow \text{inf } 1 \text{ h}$

$$\text{Dose} = \frac{\text{quantité}}{\text{temps (h)} \times 3}$$

(15)

* Convulsion chez enfant :

- Clinique : inconscient, cyanose à la face,
⇒ PLS / O₂ thérapie ou 2 l/min si masque et l/min
Dextro / T° / Voie d'abord
- ⇒ Valium (Diazépam) en Intra Rectale
0.5 mg/Kg
2 min - 5 min si : Pas d'Amélioration
" 2ème Valium 0.5 mg/Kg en IR
" 3ème Valium 0.5 mg/Kg en IR
si : Pas d'Amélioration : en 2 - 5 min
⇒ Gardénal (Phéno-barbital)
0.2 mg/Kg max 40 mg 15 min
dans 150 mg SG 5% ou SSI en IV
⇒ Rechercher la cause si : fièvre ⇒ foyer
si : infec ⇒ Augmentin 0.1 ddp 2x1j
pas de foyer ⇒ TLT + ECBU
si : infec ⇒ Orokem 0.1j
0.1 ddp 2x1j
si : Trauma ⇒ Scanner!

Si = Apyrétique + crises $\Rightarrow$ Avis Neuro!
EEG + TDM.

Depakine $\xrightarrow{\text{QSP} = 0.5 - 0.7 \text{ g}}$
 10 mg/kg/j en attendant consultation
Neuro!

* Convulsion apyrétique $\Rightarrow$ TA + Bilan Métab
ionog $\rightarrow$ + Ca + Mg + glycémie + FO +
TDM $\Rightarrow$ Tit de cause.

* Convulsion pyrétique $\Rightarrow$ PL + EEG si =
crise complexe $\Rightarrow$ TDM + IRM.

NB = Diazepam est CI chez l'enfant
 $\Rightarrow$ G. Ordinal 20 mg/kg ds SSI $2 \times 1 \text{ g}$

* Déshydratation aigue de l'enfant:

- Clinique = pli cutané, yeux cernés, hypotonie, perte du poids, soif, sécheresse muqueuse, $\Rightarrow$ glycémie / ionogramme sanguin et urinaire / urée / Créat / K^+ (si diarrhée / Vomissements)

- * Yeux cernés + Fontanelle déprimée $\Rightarrow 5\%$
- * Yeux cernés + FA + plâie cutanée $\Rightarrow 8\%$
- * YC + FA + PC + TRC $\Rightarrow 10\%$
- * YC + FA + PC + fièvre $\Rightarrow 10\%$ $\ominus$ Lano
- * YC + FA + PC + Soif $\Rightarrow 10\%$
- * YC + FA + PC + Trouble neuro $\Rightarrow 15\%$
(Coma / Convulsion)

ou
$$\frac{\text{Poids récent} - \text{Poids (Nau)}}{\text{Poids Récent}} \times 100 = \%$$

* Réhydratation:

- $5\% \Rightarrow 90\%$: SRO 50 cc/Kg en 4h
- 80% Amélioration $\Rightarrow$ Libérer malade
- 100 cc / Kg 4h - 12h - 24h

- 5-10% $\Rightarrow$ $VO = SRO$ 100 cc / Kg en 4h
 $\oplus$ 4h si: Amélioration $\Rightarrow$ Libérer malade
- 10% $\Rightarrow$ $VO =$ si possible SRO 100 cc / Kg en 4h
 $\ominus$ dans cdc 3min $\oplus$ dans ds vend 3min
 pas possible $VO \longrightarrow IV$
 si: Diarrhée freq / Vomissements incessants
 $TRC > 4$ sec / Trouble Nemo $\Rightarrow$ $\textcircled{H}$ IV

* CAP:

- 0-30 min: 20 cc / Kg SSI
 ex: 5Kg $5 \times 20 = 100$ cc / 30 min
- 30 - 2h: 30 cc / Kg SSI / 4,5
 $\text{Débit} = \frac{\text{30 cc}}{3 \times \text{temps(h)}} = \text{gtt/min}$

- * Enfant pas uriné = 10 cc / Kg SSI en 1h
 Renouveler une fois
 Lasix 1mg / Kg en IV $\Rightarrow$ Réal si uriné
- $\Rightarrow$ Au moment où il uriné on continue
- 2-6h: 50 cc / Kg SIR = 12 = Débit /
 tous ça c'est les pertes antérieures / gtt / min
- 6-12h: 50 cc / Kg SIR = 18 = gtt / min
 Pertes en cours!
- $\rightarrow$ Malgré Lasix si pas uriné $\Rightarrow$ Réal
 insuffisance rénale

Ration de base :

• 12 - 24 h :

0 - 10 Kg $\Rightarrow$ 1000 cc/Kg / j dans 12 h $\Rightarrow$ 36

10 - 20 Kg $\Rightarrow$ 1000 + 500 cc/Kg $\Rightarrow$ 36

على كل Kg متوقع 10 $\rightarrow$ 10 قاع 10

③ 20 Kg $\Rightarrow$ 1000 + 500 + 200 cc/Kg $\Rightarrow$ 36

على كل Kg المتوقع 10 $\rightarrow$ 10 ② 10 $\rightarrow$ 10 ④

* ienogran = Hypo Na δ^- Na $\angle$ 120

$\Rightarrow$ Pas urine : supplémentation $\angle$

10 cc/Kg de SSI dans 01h.

$\Rightarrow$ Urinée : complète le schéma

* δ^- : SIR en manque

$\Rightarrow$ SG 5% + 2 meq Na / 100 cc

chaque degré au delà de 38°C

on ajoute 10 cc/Kg + Perfalgan inj

* En cas de collapsus : Hypo TA $\angle$

20 cc SSI / Kg en 20 min

* Fièvre à 40°C

① dans risque de convolution int. = 39¹²
 ⇒ Paracétamol suppo

+ Dose de charge 25mg/Kg
moyen physique (poche de glace)
Si: $T_0 < 39^{\circ}\text{C}$

Pass d'Amélioration $\leftarrow 39^{\circ}\text{C}$

$\Rightarrow 12.5 \text{ mg/Kg}$ après 1-2h

Par d'1 Ame $\frac{1}{2}$ Iteration

Aspirine in 10 mg/kg en 1M
 en per 100 g in 100 g dans 5 cc SS
 Si: $T = 39^{\circ}\text{C} \Rightarrow$ Bilan préop
 * 1 mls $\rightarrow 33\text{Kg}$

* 1 min $\rightarrow$ 33 kg

⇒ Paracétamol Δ 15mg/kg 1VO en perfusion

* $\ominus$ 1 mois :

$P \Rightarrow 12,5 \text{ mg/kg}$ $T_j + \text{maximaler Phosphor}$
 Pas d'Amélioration $\Rightarrow \textcircled{H}$

Das d' Amerikation $\Rightarrow$ (H)
Bilanz PO = FNS / CRP / VS

$\Rightarrow$ TLT de face

$\rightarrow$ CV

$\Rightarrow$ ECBU + Antibiotika

lien $\rightarrow$ PL $\Rightarrow$ Avis pediatric!

* Crise d'asthme :

⇒ 01 Séance de Nébulisation

+ 01 cc Salbutamol + 03 cc SSI

+ 40mg Solumédrol en IVD

ou 200 mg HHC en IVD

Si : Pas d'amélioration après 20 min

⇒ 01 Séance de Nébulisation

+ 01 cc Salbutamol + 03 cc SSI

après 20 min Pas d'amélioration

⇒ 01 Séance de Nébulisation

+ 01 cc Salbutamol + 03 cc SSI

après 03 séances Si : pas d'Amélioration
ou aggravation

⇒ chaque 1h une séance 01 de
Nébulisation

⇒ 01 Séance de Nébulisation

+ 01 cc Salbutamol + 03 cc SSI

+ 015 mg Atrovent

Si : Pas d'Amélioration

⇒ 01 Séance de Nébulisation

+ 01 cc Salbutamol + 03 cc SSI

+ Sulfate de Mg diluée en 100 cc SG 5h
01g (01 Amp ou 1/2 Amp) en 15 min
Si = Pas d'Amélioration

⇒ Avis Pneumo!

• BPO = FNS / VS / CRP...

• TLT = pneumonie...

Si = Gêne sévère ou Pause resp
⇒ Avis Réa!

Si = Non Salbutamol en IV

+ Sulfate de Mg en 15 min
⇒ élimination en Réa / Pneumo!

* Gêne modérée = (H)

⇒ 1 Séance de Nébulisation

+ 01 cc Salbutamol + 03 cc SST / 6h

+ 40 mg Salbutamol 18h

ou 200 mg HHC 18h

Si = fièvre ⇒ Parfalgan 18h

Si = Pneumopathie ⇒ Amox my 1g / 18h

ou Augmentan my 1g / 12h

ou Claforan my / 12h

CAT

* Légère : Ventoline 2 bouffes / 20 min
Si : ça passe pas après 1h } modérée

* Modérée : Nébulisation 1cc Astalin diluée
dans 4cc SSI / 20 min
CTC (Solumédrol 1mg / Kg en IV)
Si : après 1h pas d'Amélioration } S

* Sévère : Nébulisation 0,03 cc / Kg Salbutamol
diluée dans 4cc SSI
CTC (Solumédrol 1mg / Kg
ou Dexa 0,5mg / Kg) + O₂

CAT

* Légère : Nébulisation 0,5 cc Salbutamol < 16 Kg
ou 1cc > 16 Kg + 3cc SSI

* Modérée ou sévère : Nébulisation
+ Solumédrol inj IV 1mg / Kg
On fait 03 séances de Nébulisation
chaque 20 min et on réévalue
à la sortie :

- 1) - Ventoline Spray 2 bouff 3x1j pdr 07j
- 2) - Solumed cp 10mg / Kg matin
pdr 05j

+ Bronchiolite chez enfant:

- Clinique = Dyspnée expiratoire, Toux Asmatiforme
 ⊖ dans Bronchiolite ⊕ dans Début asthme
 Raies Stridements.

* PDF = 01 Séance de Nebulisation } pdt
 + 0,03 mg/Kg Salbutamol (Asthalin) } 20
 + 03 SST ex = 10 Kg x 0,03 = 0,3 } min
 Si : Amélioration ⇒ Trk de Sortie

Ordonnance :

- 1/ - Salbutamol sirop _____ 0,507j
 01 cà m 2x/j
- 2/ - Célestène gtt _____ 0,505j
 10 gtt / Kg / j le matin
- 3/ - Prima lan sirop _____ 01 flacon
 01 cà m / j le soir
- ou Totinal sirop _____ 01 flacon
 01 cà m / j le soir
- ou Histagan sirop _____ 01 flacon
- ou Deslor sirop _____ 01 flacon
 01 cà m / j le soir

Si Pas d'Amélioration $\Rightarrow$ 2^{ème} Séance
 $\Rightarrow$ 0,03 CC Salbutamol + 03 CC SSI en dernière
 Si Pas d'Amélioration $\Rightarrow$ 3^{ème} Séance
 $\Rightarrow$ 0,03 CC Salbutamol + 03 CC SSI + CTC
 . CTC $\Rightarrow$ Célestène glt
 10 gtt / kg sur place
 ou Salbutamol 2 mg / kg en IM sans dépasse 40
 ou HHC 5 mg / kg Dose Max 200 mg IM

Si: 03 Séances Non Réponse $\Rightarrow$ (H)
 Bronchite + 03 mois $\Rightarrow$ (H)
 Bronchite Sévère $\Rightarrow$ (H)

Cardiopath / Malnutrition ...
 Si: TLT anormal $\Rightarrow$ Avis pédiatrie!

Salbutamol si
 1/2 cāc 2-3 x 1j Si 01 mois - 2 ans
 01 cāc 2-3 x 1j 2 ans - 6 ans
 01 cāc 3 x 1j 6 ans - 12 ans
 (H) $\Rightarrow$ Bilan: FNS / glycémie / TP / Méc / Créat
 ionogramme S 1 CU
 $\Rightarrow$ TLT de face $\Rightarrow$ ECBU.

* Constante initiale chaque 2h = FR - FC - SnO_2
24h $\Rightarrow$ Diurèse / poids
 O_2 thérapie / Arrêt d'alimentation orale,
Aspiration 14h au @ 24h

$\Rightarrow$ Séances de Nébulisation 16h
0,03 cc Salbutamol + 0,03 cc SSI

Si = fièvre $\Rightarrow$

ATB = Claforan 100mg/Kg/j 16h 4x/j IV

CTC = HHC 500mg/Kg/16h

$\Rightarrow$ Rehydratation (voir b schémas !)

CTC = Matin à jeun AH = Soir

* Laryngite chez l'enfant :

• Clinique : Dyspnée inspiratoire / Raie / Voix rauque

* PDI : 0,6 mg Dexa en IM Dose max = 12 mg

Si : Amélioration $\Rightarrow$ Trt de sortie

Si : Pas d'Amélioration après 01 h

$\Rightarrow$ Dexa 0,4 mg en IM

Si : 01 h après pas d' (H)

$\Rightarrow$ 01 Séance de Nébulisation :

01 cc adrénaline + 2 cc Dexa + 3 cc S

Si : Amélioration $\Rightarrow$ Trt de sortie

Ordonnance :

1) - Celestène gtt _____ QSP : 05 j
10 gtt / Kg ex : 10 Kg $\Rightarrow$ 100 Dose Max : 200 j

ou
= Sclupred cp 5-20 _____ QSP : 05 j
02 mg / Kg / j le matin DM = 40

2) - Augmentin susp _____ QSP : 10 j mg
01 ddp 2x / j

Si : Non Réponse sort (H) ou Avis pédiatre !

* Sinusite aigüe :

- Cliniques : obstruction nasale, douleur, écoulement purulent. Muin ou bñ poster bñ à palpation
- * PDF : Rx de maxillaire faciale : opacités confirmées → PDM
- en Urgence ⇒ 01 flacon perfalgan 15min
ou 01 Amp Chefenol en 1H
+ O₂ thérapie 5-10min
ou Pamogésic 1/2 Amp } Rare.
ou Valium 1/2 Amp }

Ordonnance :

- 1) - Augmentin 1g ——— GSP = 10j
01 cp 3x 1j
- 2) - Nifluril gtt 250 ——— 01 Hc
(AH) 01 gtt 2x 1j au milieu repas
- 3) - Proton gel 20 mg ——— 01 Hc
01 gel 1j

* Angine de l'enfant :

P = 10 Kg 2 ans

• Fièvre = Motif +++ • examen de gorge = Angine

Ordonnance :

1) - Clamoxyl sup 125/250/500 ——— Dose 10j
 $50 \text{ mg/Kg} \times 10 = 2 = 250$ 2-3 x 1j
 1 cà m 2 x 1j

2) - Paracétamol sup 1 sup / sach 100/150/200/300
 50 mg/Kg $500 = 2 = 250$

3) - Algifen sup ——— 01 flacon

AI + ✓ 01 ddp (10 Kg) / 8h

Antipyrétique en Alternance avec paracétamol

* Angine + Fièvre + Vomissements

1) - Clamoxyl sup 250 ——— Dose 10j
 01 cà m 2 x 1j

2) - Domperidone sup ——— 01 flacon
 Vomss 01 ddp 2 x 1j 1/4 h avant repas

3) - Paracétamol sup ——— 01 bte
 01 sup 18h

4) - Algifen sup ——— 01 flacon
 01 cà m 18h en Alternance avec Paracétamol

* Angine + Fièvre + Douleur Abdominale

1/ - Clamoxyl 2/ - Paracétamol sirop

Douleur { 3/ - Smecta sachet 01 sachet 2x tj 01 bte
 4/ - SRO Sachet 02 sachets
 01 sachet dans 01 l d'eau.

Douleur Abdominale ⇒ 5/ - Débridat sirop 01 flacon
 01 cam 2x tj

Si: Angine + Fièvre et mal logie le T et
 la T = tj ↑ soit: pas d'Angine ou
 Amox non efficace.

Ordonnance:

1/ - Augmentin sirop 01 ddp (10 Kg) 2x tj QSP: 10g

2/ - Efferalgan sirop 01 cam 1 bte 01 flacon

Douleur de gorge ⇒ 3/ - Maxilase sirop 01 cam 3x tj 01 flacon

* Angine + fièvre + Allergie aux Pén
 1) - Josacine sup 250 ——— QSP = 10j
 ↓
 10cām 2x1j
 ou Zedac sup 25/50 ——— QSP = 5j
 ↓
 10ddp 2x1j $\ominus 25\text{Kg} \Rightarrow 25 \oplus 25 \Rightarrow 50$
 ou Rovamidal sup 37500 U1 ——— QSP = 10j
 ↓
 10cām 2x1j

* Angine 2ans $\ominus \Rightarrow$ 90% virale
 1) - Efferalgan sup ——— 01 flacon
 ↓
 10cām 18h
 2) - Eau de mer

éviter ATB sauf si = fièvre $> 38^\circ$
 * Après 4ans si =
 Angine à Répétition $\Rightarrow$ bilan
 ASLO (+) si > 200

Extraitine pour lutter contre RAA
 1) - Extraitine 0,6 M $\ominus 30\text{Kg}$ 03 inj
 1,2 M $\oplus 30\text{Kg}$ $\downarrow$
 01 inj / 21j en IM strict
 dans un milieu hospitalier
 disponible : O_2 / Adrenaline / CTC
 solumedrol ou HHC IV

* Angine chez Adulte :

1/ - Clamoxyl 1g ——— QSP 7j
 01 cp 2x 1j

2/ - Paralgon 500 ——— 01 1/2
 01 cp 3x 1j

3/ - Vit C cp ——— 01 1/2
 01 cp 1j le matin

4/ - Hexamyl ——— 01 glucan
 01 3x 1j - medepan pas 01 j

ou Maxilase 500 ——— 01 glucan
 01 ca m 3x 1j

ou Augmentin 1g

ou Amoclan Bich

= 01 cp 2x 1j

ou Lexin 1g

01 cp 2x 1j

si = fièvre

=> Amox mg 1g

* Covid 19 :

- clinique : fièvre, Toux, myalgies, dyspnée, perte de goût et odeur, cas similaire...
- FDR $\Rightarrow$ (H) pas FDR $\Rightarrow$ Trt Ambulatoire

ou Tests :

- ① * Test rapide Antigénique Covid 19
Si (+) confirme le Dg peut (-) après 5-7 j de sympt.
 - ② * Test R-T PCR Covid 19 (-) + j
 - ③ * Sérologie Covid 19 IgM + IgG.
 - ④ * TDM Thoracique Recente Ancienne
- Suivi jour $\Rightarrow$ Trt de Soins

Ordonnance :

- 1 - Augmentin cp 1g ——— 01 cp 2x 1j 01 bte
- 2 - Zomax cp 250 ——— 02 cp 1j 1er j 01 cp 1j le reste des 4j 01 bte
- 3 - Vit C cp ——— 01 cp 1j le matin 01 bte
- 4 - Zinc cp 10mg ——— 01 cp 1j 01 bte

51 - Mg Amp $\xrightarrow{01 \text{ Amp } 2 \times 1 \text{ j}}$ 01 Lte

61 - Vit D Amp $\xrightarrow{01 \text{ Amp } 2 \times 1 \text{ j}}$ 02 Lte

* Sujet = HTA / Diabétique / Cardiopathologie
 $\Rightarrow$ (H) pas CTC avant 07 j $\text{SaO}_2 < 92\%$
 $\Rightarrow$ O_2 thérapeut / ATB / CTC / Anticoagulant
Hydroxychloroquine 200.

$\Rightarrow$ Bilan = FVS / glycémie / VS / CRP / Urée /
Créat / ASAT / ALAT / ionogramme / D-D

• O_2 thérapeut 08 - 10 l dépend SaO_2
30 l si 92% ou $\ominus \Rightarrow$ ARIS Rén 1

• ATB si = fièvre > 5 j, CRP $\uparrow$
réapparition de fièvre, Toux persistante

Augmentin 1g mg 3x 1 j pdr 10 j
ou Claforan 1g 500 mg pdr 10 j 1g/8h
ou Ciprofloxacine 200 pdr 10 j
dans perfusion 1h 2x 1 j

• Anticoagulant: Lovenox si = DD > 500,
 IMC > 25, adulte, Md chronique
 Lovenox 0,4 en sc 1x1 ∇ QSP: 10j
 IMC < 30 $\Rightarrow$ 0,4
 IMC > 30 $\Rightarrow$ 0,6

ou injecter 3500 UI < 30 kg
 7500 UI > 30 kg 2x
 QSP: 10j jusqu'à 01 mois si = maladies
 si = DD $\ominus$ 500 $\Rightarrow$ Arrêt Lovenox

si = DD $\uparrow\uparrow$ on $\uparrow$ la dose si men $\Rightarrow$ Avis Cardio

100 UI/kg chaque 12h pour Lovenox

175 UI/kg chaque 24h par inject

• Bilan chaque 3-5j:
 FVS / VS / CRP / Mée / Créat

* CTC après 07 QSP: 5-10j

Solumédrol 40mg en IV/12h 2x ∇

ou Dexa 0,4mg Amp ∇ 0,1-0,2mg/kg ∇

ou Solupred 8mg 0,75-1,2mg/kg ∇
 sans dépasse 32mg

* Diarrhée Aigue : Liquide glauqueuse

① * Diarrhée aigue liquide :

1) - Smecta Sachet _____ 01 Lte

- 2 ans 1/2 Sachet 2x1j
 - 2 - 6 ans 1 Sachet 2x1j
 - 6 ans 1 Sachet 3x1j

+ SRO.

2) - SRO sachet _____ 02 sachets
 01 sachet dans 01 l d'eau.

5% 50cc / Kg 1j

10% 100cc / Kg 1j

Si : Pas d'Amélioration

1) - Tiorfan Sachet 10/30 _____ 01 Lte

10 (1 mois - 9 mois $\Rightarrow$ 1 sachet 2x1j
 9 mois - 30 mois $\Rightarrow$ 2 Sachets 2x1j

30 (30 mois - 9 ans $\Rightarrow$ 1 Sachet 2x1j
 9 ans $\Rightarrow$ 2 Sachets 3x 2x1j

2) - SRO _____ 03 Sachets

01 sachet dans 01 l d'eau.
 chaque diarrhée un sachet.

②* Diarrhée glairo-sanglante : ATB
 1/ - Bactrim sup 240 ——— QSP : 07 j
 01 cam $2 \times 1j$
 $30 \text{ mg/Kg/j} = 2 \text{ fois} = ?$

2/ - Flagyl sup 125/250 ——— QSP : 07 j
 (Métronidazole) 1 cam $2 \times 1j$
 30 mg/Kg/j

3/ - SRG sachet ——— 02 sachets
 01 sachet dans 01 l d'eau.

8 : fièvre $\rightarrow$ (H)
 (entre Smecta) n'arrête pas la diarrhée

$\rightarrow$ 1/ - Flagyl inj 12h
 $20 \text{ mg/Kg/j} = 2 \text{ fois} = ?$

2/ - Bactrim 30/6 perfusion

0,2 cc/Kg = 2 fois $2 \times 1j$
 ou Ampicilline inj 100 — 120 mg/Kg/j
 12h $2 \times 1j$

ou Augmentin

ou Claforan

3/ - Perfusé pédiatrique 18h.

* Epistaxis chez l'enfant :

- POF : Méchage nasal + 1 -
1/2 Amp Dicynene IV
ou 1/2 verre eau ou en IM.

Ordonnance :

1 - HEC pde _____ of tube

ou app 2x1
à Répétition :

Bilan : FNS (playmets) / TP / TCK / prise TA

Si : (A) ↙
Si : chronique $\Rightarrow$ Avis ORL!

* Urticaire :

- Clinique : Contours nets, prurit, vaille #, relief bombé, d'origine médicamenteuse.

* PDF :

- 40mg Solumédol en IV 1h
- Pas amélioration : 200mg HHC en IV 30'
- Pas amélioration : AH
- 01 Amp phénergan en IV

Ordonnance :

Telfast
1/ - Telfast 180 _____ 01 bte
(AH) 01 cp / j le soir

Resp Cutané
120 180
2/ - Solumédol 20 _____ 01 bte
(CTC) 02 cp / j le matin

ou
1/ - Zyrtec gtt _____ 01 flacon
20 gtt le matin (E) 10 gtt

2/ - Titalin cp _____ 01 bte
01 cp / j le soir

Enfant :
⊖ 2 ans Primaban 01 cà c / j le soir
⊕ 2 ans Zyrtec 10 gtt le soir
Clarytine sup 01 cà c / j le soir
⊕ 6 ans même que Adulte

* Zona :

⇒ éruption en bande vésiculeuse.

Ordonnance :

1/ - Aciclovir cp 800 _____ GSP = 07-10g

01 cp 5x1j 4mg1j

2/ - Fosine Aqueuse sol _____ 01 flacon

01 Appl1j

3/ - Dolyc 1g _____ 01 bte

Douleur 01 cp 3x1j

2ème CAT :

1/ - Aciclovir cp 800 _____ GSP = 10g

02 cp 2x1j

2/ - Aciclovir pde _____ 01 tube

01 Appl1j

3/ - Xamadol cp _____ 01 bte

01 cp 2x1j

3ème :

1/ - Aciclovir cp 01 cp 5x1j GSP = 10g

2/ - Fosine Aqueuse sol 01 Appl1j 01 fl

3/ - Tramadol cp 01 cp 2x1j 01 bte

ou Tegre sol 200 cp 01 cp 1j 01 bte

ou Zyrica 150 01 cp 2x1j 01 bte

4/ - Neurvit B₁ B₆ _____ 01 bte

01 cp 2x1j (41)

* Hélopathies fonctionnelle :

Diarrhée $\Rightarrow$ Coproparasitologie des selles

Constipation $\Rightarrow$ TSH, FT_3 , FT_4

Douleur localisée $\Rightarrow$ échographie Abd

Diarrhée fréq - te $\Rightarrow$ Md Coelhaque

Dosage Ig A antitendomyosium

* Trt en urgence : Anxiété

$\Rightarrow$ 01 Amp Prümperan (calmer / Antémétique)

ou 01 Amp phenergan en IM + O_2 therapy

ou 01 Amp Sparfon en IM

Ordonnance :

1) - Sparfon cp _____ 01 bte

01 cp 2x1j

2) - Detsudat cp 200 _____ 01 bte

01 cp 2x1j

ou Dusphtakalin gel 200 _____ 01 bte

01 gel 2x1j

ou Transacalm gel 200 _____ 01 bte

01 gel 2x1j

Constipation $\Rightarrow$ 3/ - Duphalac sachet _____ 01 Lte
ou 01 sachet 2x1j
ou Ezilax sup _____ 01 flacon
01 cās 2x1j

Diarrhée $\Rightarrow$ 4/ - Imodium gel 2mg _____ 01 Lte
02 gel 1j

après chaque diarrhée peut $\oplus$ 01 gel.

Anxiété $\Rightarrow$ 5/ - Zysanxia cp _____ 01 Lte
1/2 cp 1j le soir

Trouble de $\Rightarrow$ ou dia-tyl cp _____ 01 Lte
Sommeil 1/2 cp 1j le soir

Dépression $\Rightarrow$ 6/ - Isoptyl gtt _____ 01 flacon
peur $\Rightarrow$ ou Laroxyl gtt

03 gtt 1j le soir
7/ - Escal $\downarrow$ cp _____ 01 Lte
01 cp 1j le soir

faussement $\Rightarrow$ Béchilix sachet _____ 01 Lte
gastroq 01 sachet 2x1j
gaz $\Rightarrow$ Eucarbon 01 cp _____ 01 Lte
01 cp 2x1j

Charbone plus cp _____ 01 Lte
01 capsule 2x1j

spasme ou Méthéoxan gel _____ 01 Lte
01 gel 2x1j (43)

* Colique Néphritique :

- Colique : Douleur unilatérale, fosse lombaire agitée, pas position antalgique, insupportable, irradie vers OGE, pas fièvre.

but : Soulager la douleur

⇒ Clofenal ou Amp en IM 3-7 min

si : pas d'amélioration

⇒ Perfusion ou flacon de perfalgan à flow

si : pas d'ⓐ

⇒ Tramgésic en SC

PDF : * Labstix : infec, sang ⇒ CN

⇒ frapper le dos en regard du rein
dédendce de la douleur

* ECBU

* échographie

Ordonnance :

1/ - Clofenal 50 _____ 01 bte

ou Feldene inj 20 _____ 01 bte
3x 1j au milieu repas
01 inj 1j en IM.

ⓐ si : CN hyperalgique ⇒ Avis Mal
pyélique 38.5°, oligo Anurie
Femme enceinte ⓐ

* Pathologie Hépatique

Clinique : Douleur en regard du foie, HD super après repas lipidique inachève vers haut clavicule CN, dg ≠ (inachève vers OGE poche chaud)

Labo : RAS x

⇒ O₂ thérapie / Voie d'abord

01 Amp Sparfon en IV

ou 01 flacon de perfalgan en IV 15 min

ou 02 Amp Sparfon dilués dans 150cc SSI ou SG 5% 30 min

Ordonnance :

1 - Sparfon cp 200 — 01 bte
01 cp 2x1j

2 - Dérivé dat 200 cp — 01 bte
01 cp 2x1j 05j

ou Busphatatin gel 200 — 01 bte
01 gel 2x1j

ou Sparco gel 200 — 01 bte
01 gel 2x1j

Vomissement ⇒ Clopramide cp — 01 bte

Dompéridone cp — 01 bte
01 cp 2x1j 1/4h avant repas

(45)

Lettre échographie : chœ confie
Permettez-moi de vous adresser le
patie ~~à~~ son ~~no~~ ~~é~~, âgé de 2 ans
aux ATCD, qui consulte ce jour pour une
CH je vous le confie pour échographie
(H) Abd

* Bilan = FNS / VS / CRP / ASAT / ALAT / GT / PA
BT / B D / BE / glycémie

(H) si Douleur + Fièvre $\Rightarrow$ Cholécystite
Douleur + Fièvre + ictère $\Rightarrow$ Angiocholite

$\downarrow$ ATB + Avis chirurgie en Urgence.

sparfloxacin 18h

penicilline 18h

prémipéran 12h

SSE 18h

ATB { Flagyl 500/12h
Ciprofloxacine 200 2x1j
ou Bactrim ou Augmentin 1g 2-3x1j
ionogramme 3g NaCl + 2g KCl

CH simple $\Rightarrow$ échographie Abd.

$\Rightarrow$ Consultation

Angiocholite $\Rightarrow$ Avis gastroentéro
chirurgie!

* Guise hémorroïdaire :

PDF: 01 Amp Valavène en IM +++
 + 01 de spargon en IV ou IM
 ou perfusion 1 flacon de perfalgan en IV
 + 01 Amp dofenal en IM

Ordonnance :

1/ - Duflo cp 500 _____ QSP 01 mss

02 cp 2x1j pdr 10j
 01 cp 2x1j le reste ds j

2/ - Titamoxine à lidocaïne supp _____ 01 lte
 01 supp 1j le soir

3/ - Titamoxine à lidocaïne pde 2/ - 01 tube

01 App 1j

constipation ⇒ 4/ - Duphalac sachet _____ 01 lte
 01 sachet 1-2x1j

Antalgique ⇒ 5/ - Divido 75 _____ 01 lte
 01 cp 1j le soir

2e Ordonnance :

1/ - Diovonor cp 600 _____ QSP 01 j

01 cp 3x1j

2/ - Hémorect crème _____ 01 tube

01 App 1j

3/- Permanganate du potassium $KMnO_3$ cp - 01 lte
01 cp 1 2P pour bain de siège

4/- Ezilax sup _____ 01 flacon
01 càc 2x 1j

Antalgique => 5/- Rapidos 50 _____ 01 lte
01 cp 2x 1j au milieu repas

~~3^e ordonnance :~~

1/- Veïnasmil gel 200 _____ 02 sps 1j
2 gel 2x 1j

2/- Hemobog crème _____ 01 tube
01 Applj

3/- Hemobog sup _____ 01 lte
01 sup 1j le soir

4/- Poncture l gtt _____ 01 flacon
06 gtt 1j

5/- Clofenal cp 100LP _____ 01 lte
01 cp 1j au milieu repas le soir

~~4^e ordonnance :~~

1/- Cyclo 3 fat gel _____ 01 lte
02 gel 2x 1j

2/- Néo-healer pte _____ 01 tube 01 Applj

3/- Trimebutine sup _____ 01 lte 01 sup 1j

4/- Voltarène cp 50 _____ 01 lte 1 cp 2x 1j
au milieu repas

* Infection urinaire :

Clinique : Brûlure mictionnelle ++, dysurie --

* PDF : Labstix

⇒ Sang, protéine +/-, Nitrite (+), Leucocytes (+)

Ordonnance : Femme

1 - Mircare sachet 3g _____ ol lte

ol sachet 1j

ou Norfloxal cp 400 _____

ol cp 1j

QSP 803j

si = persistance ds symp

⇒ ECBU + Antibio

Ordonnance : Homme

1 - Bactrim cp _____

ol cp 2x1j

QSP 07j

2 - Nitroal cp 100 _____

ol cp

3x1j

QSP 07j

3 - Dolyc 1g _____

ol cp

2x1j

ol lte

ou Clafenal cp 50 _____

ol cp

2x1j

ol lte

pdr 3 - 5j au milieu repos

Antiseptique
urinaire

Si = Persistance de symp $\Rightarrow$ ECBU + Antibiotique

ATB =
 pas d'exercices
 forces
 régime de
 l'enduite

1) - Ciprolan 500cp
 01cp 2x1j φ SP = 10j

2) - Nitrofur 100cp
 01cp 3x1j φ SP = 07j

3) - Clafenal 50cp
 01cp 2x1j au milieu repas
 01kte

1) - Chloracel 500cp
 01cp 2x1j φ SP = 10j

2) - Nitrofur 100cp
 01kte

Naxolin 01cp 3x1j pdr 07j

3) - Delyc 1g
 01cp 2x1j 01kte

1) - Bactium cp
 01cp 2x1j φ SP = 07j

2) - Nitrofur cp 100
 01cp 3x1j 01kte

3) - Rapichlor cp 50
 01cp 2x1j 01kte

1) - Lexin 1gcp
 01cp 2x1j φ SP = 10j

(50)

1/ - Augmentin 1g _____ QSP = 10g
01 cp 2x 1g

2/ - Nitrofur cp 100 _____ 01/ste
01 cp 3x 1g

3/ - Rapinidur cp 50 _____ 01/ste
01 cp 2x 1g

• Fem. enceinte

* 1/ - Clamoxyl 1g cp _____ QSP = 10g
01 cp 2x 1g

ou Augmentin

ou Cloracef 500 cp _____ QSP = 07g

ATB prescrit $\Rightarrow$ Croken 200 cp _____ QSP = 10g
01 cp 2x 1g

* Enfant 30 mois - 12 ans (100) 6 mois - 30 (40)

1/ - Croken 40/100 (0.8 mg/kg/g) 2x 1g

2/ - Paracétamol suppr _____ 01/ste 01 suppr

ou 1/ - Bac trim suppr 240 _____ QSP = 7g

1^{re} épisode dsz garçon $\Rightarrow$ Avis pédiatrie en Cystométrie

2^{ème} épisode dsz fille ds même année $\Rightarrow$ Avis pédiatrie! $\uparrow$
 $\Rightarrow$ Ht infection urinaire ds enfant $\uparrow$

* Morsure par un animal

- * pas de lésion ni atteinte de membre $\Rightarrow$ Rien
- * Morsure / griffure / Léchage / att. membre $\Rightarrow$ VAR + Soins locaux

① / * Petite lésion = VAR + VAT

I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ I₆ I₇

en SC périmétrical

- Adulte + enfant > 5 ans $\Rightarrow$ 0,2 cc en SC
- enfant < 5 ans $\Rightarrow$ 0,1 cc (1/2 Amp)

+ ATB =

Adulte $\Rightarrow$ Augmentation cp 1g $\xrightarrow{2 \times 1g}$ $\text{QSP} = 10g$
0,1 cp

Enfant $\Rightarrow$ Augmentation sup $\xrightarrow{2 \times 1g}$ $\text{QSP} = 10g$
0,1 dd/p

δ^- = chien malade

$\hookrightarrow$ Rappe $\xRightarrow{I_{10}}$ I_{11} I_{15}
en intradermique

Ⓐ + Ⓔ > 5 ans $\Rightarrow$ 0,2 cc en ID en 2 points

Ⓔ < 5 ans $\Rightarrow$ 0,1 cc en ID

• Rappel: T_{30} T_{90} $\Rightarrow$ en ID si = Grande lénax (Saurage)

Sans locaux + VAR + SAR

flacon complet au nr du plaie

ou T_1

T_7 dans un jour parmi ces 7 après devent?

* Ferme enceinte $\Rightarrow$ VAR + SAR pas I ma eff.

* Piqure de Scorpions

O_2 thérapie 10-15 min

+ 40mg Sotumédol en IV 2-4h

* larence en Vit D₃

* Dosage demandé en cas :

- Md Ceatrague - Md de Grehn - RCH
- Stéatose hépatique - insuff hép
- Depakine / Tegretol / Phénobarbital

⇒ Malabsorption ⇒ Trt préventif

01 Amp de Vit D₃ 03-06 mois

* Chute sujet âgé / insuff Renale / Rachitisme ostéomalacie

01 Amp de Vit D₃ chaque 03 mois

Vit D₃ normal > 30 ⇒ Rien

20-30

⇒ 01 Amp D₃ / mois
pdt 02 mois

< 20 ⇒ 01 Amp D₃ 1/15

Amp 200.000 UI

pdt 2-3 mois

* Œdème de Quinck :

• Clinique = fièvre, urticaire, œdème aux v. usages
levées ↑ volume, palais gonflé
⇒ O₂ thérapie / V_{O₂} d'abord / TA / T°.

en urgence : 40 mg Salumédrol en IVD
ou 200 mg HHC en IVD

+ 01 Amp de phenergan en IM 1-2h
Ordonnance : CTC / 6h.

1 - Telfast cp 120 ——— 01 h₂
01 cp / j le soir

2 - Supradin cp 20 ——— GSP = 05 j
02 cp / j le matin

Si = 40 mg Salumédrol après 1h pas d'ⓐ
⇒ 200 mg HHC en IVD

Si = Dyspnée ⇒ 01 séance de Nebulisation
01 cc Adrenaline } 15 min
+ 03 cc SSI

ou 0,25 - 0,5 d'Adrenaline SC ou IM 15 min
0,25 d'Adrenaline en IM

Si = Non Réponse ⇒ ⓐ en médecine interne
ou Avis Réu!

* Impétigos

⇒ infection bactérienne de la peau autour des orifices, couleur de miel ⇒ éruption
CRP = 0 Atteinte Rénale (GMA) Score de 0 à 5
L → TA ↑, Labstix ou CU (protéines)

Ordonnance :

- 1 - Kéfolal sup 125/250 ——— DJP: 10g
01 cam 2x1j 50mg/kg/j
- 2 - Fusidine pole ——— 01 tube
01 App 2x1j
- ou Hexamidine sel ——— 01 flacon
01 App 2-3x1j

* Kyste synoviale

⇒ femme ++ formation d'écaille au vr pignet
confirmer par = échographie de parties molles

Ordonnance : Si : Docteur

1/ - Rapidos cp 50 ——— 01 Lte
01 cp 2x1j au milieu repos

2/ - Neurob B₁ B₂ ——— 01 Lte

01 cp 2x1j + Bandage
en Aris orthope ——— 6 mois au ☉.

différence
des nerfs

* Lumbago

فنت ثقيت يوكيت

- Cliniques Douleur vive, bas de dos, musculaire
↳ ne dépasse pas les genoux.

⇒ 01 Amp Voltène en IM
Si = CI 01 flacon paralgan en IV

Ordre de :

1/ - Dolyc 1g cp _____ 01 Ut

01 cp 3x1g

2/ - Voltène pde _____ 01 tube

01 Appli - 2x1g

3/ - Mydocalm cp 150 _____ 01 Ut

01 cp / j le soir

1/ - Rapidos cp 50 _____ 01 Ut

01 cp 2x1g au milieu repas

2/ - Tabiflex col _____ 01 tube

01 Appli

3/ - Keferlech parth _____ 01 Ut

01 parth / j

4/ - Mydocalm 150 cp _____ 01 Ut

01 cp / j le soir

* Lombosciatalgies :

- Clinique : Douleur lombaire + souffrance Neuro
 ↳ déposer les genoux + formuler
 ⇒ 01 Amp Voltène en IM
 ou parafongum 01 flacon en IV.

Orda ce :

- 1) - Nurodo cp 75 _____ 01 Lte
 01 cp 1j au milieu repas le soir
- 2) - Dolyc cp 1g _____ 01 Lte
 01 cp 2-3x1j DM = 6g
- 3) - Kefentech path ou Voltène p de
 01 path 1j 01 App 1j
- 4) - Hydorol cp 150 _____ 01 Lte
 01 cp 1j Fe soir

-
- 1) - Cycladol gpl 200 _____ 01 Lte
 01 gel 2x1j au milieu repas
 - 2) - Solumédrol inj _____ 2-3 inj
 01 inj 1j en IM

- estomac ⇒
- 3) - Antag 20 gel _____ 01 Lte
 01 gel 1j
 - 4) - Neurorib B₁ B₆ _____ 01 Lte
 - 5) - Dolyc cp 1g 2x1j 1cp 2x1j

- 1) - Clofenal cpo 01 lte
 01 cp 2x 1j am milieu 1e pas 01 lte
- 2) - Dolyc cp 1g 01 lte
 01 cp 2-3x 1j
- 3) - clofenal 2mg 02 lte
 01 mg 1j en 1M
- ou fenedène 20mg 06 lte
 02 Amp 1j en 1M 1er j
 01 Amp 1j en 1M 2e j
- 4) - Voltale pde 01 lte
 01 App - 2x 1j

Si = Hyperalgique / paralysie / sd grave
 de cheval → Avis chirurgie!

* Torticolis :

Lum ——— bazo .
 haut ——— le
 ↑

- Clinique = Douleur l'ân du cou ⇒ faux geste

⇒ Diclofennac 75 en IV 01 Amp
 ou 01 flacon de peralgan en IV .

= Ordonnance :

- 1) - Zopam cp ——— 01 bte
 01 cp 2 x 1j au milieu repas .
- 2) - Mydocalm cp 150 ——— 01 bte
 01 cp 1j le soir

* Cervicobrachialgies :

- Clinique : douleur au nv du plexus brachial
irradie aux membre sup, progressive
+ souffrance Neuro
⇒ 01 Amp chloral en IV ou perfus

Ordonnance :

1) - Xydol 400 _____ 01 ste
01 gel 2x 1g au milieu repas

2) - Neurontin B₁ B₆ CP _____ 01 ste
01 cp 2-3x 1g

3) - Chloral pde _____ 01 tube
01 Appl

4) - Probongel 20mg _____ 01 ste
01 gel 1g

1) - Céliprex gel 200 _____ 01 ste
01 gel 2x 1g au milieu repas

2) - Dolyc 1g _____ 01 ste
01 cp 2-3x 1g

1) - Chloral in 75 _____ 01 ste

ou Profund in 100 01 ste
01 in 1g en IV

ou Fe ldene

(60)

* Cause de Migraine :

- Clinique : Douleur unilatérale pulsatile
- * PDF : O_2 5-10 min ou flacon peralgom 1 VD
 $\Rightarrow$ 01 Amp pramperan en IM
ou 1/2 Amp en IV diluée
- * PDF : $\Rightarrow$ 01 Amp Voltarene en IM
+ 1/2 Amp pramperan diluée en IV
ou peralgom + Voltarene

Ordonnance :

- sign $\rightarrow$ digestifs $\Rightarrow$
- 1 - Voltarene 50cp $\frac{01cp}{2x1j}$ $\frac{01ste}{01ste}$ ou milieu repas
 - 2 - Metoclopramide cp $\frac{01cp}{2x1j}$ $\frac{01ste}{01ste}$ 1/4 h avant repas
 - 3 - Dolyc 500cp $\frac{01cp}{2x1j}$ $\frac{01ste}{01ste}$

-
- 1 - Aspegic 500cp $\frac{01cp}{2x1j}$ $\frac{01ste}{01ste}$
 - 2 - Dolyc cp 1g $\frac{01cp}{2x1j}$ $\frac{01ste}{01ste}$

* Trt de fond:

1 - Migranem cp φ SP 01 mois
et cp $3 \times 1j$ et 1/2

ou Summigran cp 01 1/2

ou Laroxyl gtt φ SP 1 mois
ou gtt 1j - 10 gtt ser 2-3 mois

ou Seglor gtt / gel φ SP 03 mois
30 gtt $3 \times 1j$ 01 gel $3 \times 1j$

Début de $\rightarrow$ Relpax cp 01 cp à la demande
cuse
si: Trt inefficace $\Rightarrow$ Avis Neuro!

* Paralyse faciale périphérique

Si = central ou déficit Neuro associé $\Rightarrow$ TDM.

$\Rightarrow$ TA / T° / Dextro

* PDF = 40mg Solumédol en IVB ou IM.

ou 100mg HHC en IVB

ou 12mg Dexta en IM.

ordonnance

1 - Solupred cp 200mg cp 10g

2 cp 1/5 le matin 5g

01 cp 1/5 le matin 5g

Antiseptique 2 - Daryo serum gtt

01 gtt 2x 1/5

01 flacon

Larmes artificielles 3 - Siccaglin gtt

01 gtt 3-4x 1/5

01 flacon

4 - Neurovit B1 B6

01 ste

5 - Pansement oculaire 01/5

+ Massages.

- 1) - Lomoxol 40 _____ $N^{\circ}=03$
 01 mg / j pdt 03 j matin
- 2) - Solupred 20 cp _____ 05 j matin
 01 cp / j
- 3) - Siccalfund gtt _____ 01 flacon
 01 gtt 4x1 j
- 4) - Dacryosérum gtt _____ 01 flacon
 01 gtt 2x1 j
- 5) - Neurivit B₁B₆ _____ 01 flacon
 01 cp 2x1 j

si: TA $\nearrow \nearrow$ $\rightarrow$ IDM.

si: $\vec{T} = 39^{\circ}, 40^{\circ}$ $\rightarrow$ pas de foyer
 $\rightarrow$ IDM $\rightarrow$ PL.

* Vertiges aiguës :

⇒ O₂ thérapie / Dextro / TA / T°

ORL ()

Faux vertiges = anxiété ()

* PDF : O₂ + 01 Amp Tanganil 500mg IV
+ 01 Amp prümperan IV diluée en 1M

Ordre :

1 - Tanganil cp 500 014te
01cp 3-51g

Vomisse

2 - Prümperan cp 014te
01cp 2x1g 1/4 avant repas.

TA ↑ → Risq AVC → Neuro
T° → pas foyer ⇒ TDM.
Céphalée (+) → TDM.

* PDF : FNS / glycémie à jeun / Urée / Créat
CT / TG / Urécémie

⇒ ECG (Anomalie coronarienne)

Si = signes de focalisation ⇒ Avis Neuro!

1 - Bitasec cp 014te
01cp 2x1g

2 - Dompéridone cp 014te
01cp 2x1g

- **Chalazion** : bord Normal, atteinte interne
- **Orgelet** : infectin de glande attachée
- **Blépharite** : bord inflammé en totalité

Ordonnance : Orgelet

1/ - Maxidrol collyre ——— 0.5 psotg
 Forakidex 0.1 gtt 3x 1j

2/ - Maxidrol pde ——— 0.5 psotg
 Forakidex 0.1 app 1j le soir

⇒ piquer avec aiguille le pus

Ordonnance : Chalazion

1/ - Cidermex pde ——— 0.1 tube
 0.1 App 1j le soir

2/ - Chibroxol gtt ——— 0.1 flacon
 0.1 gtt 3x 1j

Conjunctivite (bact / virale / allergique)

Ordonnance : Conjunctivite bact

⇒ gtt + pde (Maxidrol ou Forakidex)

ou

1/ - Chibroxime ——— 0.1 flacon
 0.1 gtt 3x 1j

2/ - Néomycine pde ——— 0.1 tube
 ou chloramycine 0.1 app 1j le soir

Ordona-se = Conjunctivite allergica.

1) - Naxia gtt _____ 01 flacon

01 gtt 3x 1j

ou Zevophta gtt _____ 01 flacon

01 gtt 3x 1j

ou Zalerg gtt _____ 01 flacon.

01 gtt 3x 1j

Primalan sup _____ 01 flac QSP=7j

01 cac 1j le soir

2) - Dacryosérum gtt _____ 01 flacon

01 instil 3x 1j

Ordona-se = Conjunctivite Virale

1) - Rifamycine Chlorbut gtt _____ 01 flac

01 gtt 3x 1j

2) - Rifamycine pdc _____ 01 tube

Neomycine pdc

01 App 1j le soir

3) - Dacryosérum gtt _____ 01 flacon

01 App 3x 1j

pas CTC

Ordona-se = Btépharite gtt

1) - Chlorobutol / Maxidrol collyre _____ 01 fl

01 gtt 3x 1j

2) - Sterdex / Maxidrol pmd _____ 01 tube

01 App 1j le soir

ou Tobrex gtt

01 gtt 4x 1j

ou Tobrex gel

01 App 2x 1j

(69)

* Fracture de l'Humérus :

⇒ Soulager Douleur : 01 flacon de parafalgan 15 min

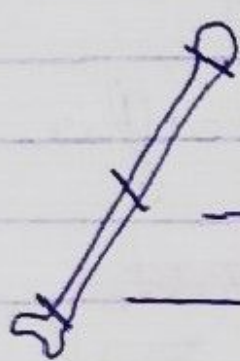
* œdème aux extrémités sup et inf

↳ Rx de l'épaule Dou G (F+P)

* Diaphyse → Rx de Totalité H (F+P)

* ex inf → Rx du coude D/G (F+P)

• Alerte plâtre BABP



Si = AH ex sup → évacuation orthopéd
Risque de luxation / Nécrose

Si = stable → BABP → Consultation

Si = Coude → BABP → Consultation

Si = Fr déplacée → évacuation orthopéd

Fractures aux Urgences : Avis orthopéd

* Fr ouvertes risque de surinfection

* Lésion neuro (sensibilité / Motricité)

* Alerte Vx (pâleur / puls) Nécrose

Articulation bloquée → Consultation

Déplacement → avis en urgence

Fr inf coude → Rx Avant - Bras

Si enfant → Avis CCI

Arrêt de travail 2 j

70

* Fracture de clavicule :

99%

⇒ Soulager la douleur : on flacon parafalgan
Rx de la clavicule face au TLT de face
les 2 clavicules pour comparer, CPC, pneumothorax

⇒ Risque de HTH Vx ⇒ Avis orthoped.
Luxation d'épaulle ⇒ " "

Rx de contrôle de 8j 15j 21j 45j
⇒ Bandage en 8.

* Fracture de l'Avant-Bras :

• chez l'enfant :

⇒ Soulager la douleur : Voltaline en 1/4 en

⇒ Applique plâtre BABP parafalgan.

⇒ Réduire au CI (Réduction)

• chez l'Adulte :

⇒ Trt chirurgical

⇒ Soulager la douleur puis consultation

posté → orthoped.

si fr infer et antérieur → Vx

fr déplacée ⇒ orthoped en urgence!

fr stable en trait ⇒ BABP

⇒ Consultation orthoped!

(71)

* Fracture de la main :

⇒ Rx de main (F+P)

1 - Scaphoïde : tiré pince ⇒ Douleur
Bulger Douleur o 1 Amp Voltarene 100
ou parafan en IV

• Si = fr stable ou non ⇒ Arelle
Antibiochimio palmar + gant plâtre
→ Consultation orthopéd!

• Fr déplacée ⇒ Avis orthopéd urgent

2) - 1^{er} Métacarpien :

⇒ Antalgique + Rx Si = fr Arelle + gant

→ Avis orthopéd usq → déplacé

3) - 2-3^e → métacarpien même CAT
fixe (2+3) ou (3+4) (4+5)
Consultation orthopéd!

4) - phalanges : vers l'avant int.

ex = 4^e + 3^e

↓

fr

* Sd grippal : fièvre 38°-40°c, Maux de tête, Toux sèche, fatigue, courbatures, frissons, Orl corps 1 mois

1/ - Humex _____ 01 bte
03 cp le jour le gél le soir
ou Dolibume _____ 01 bte

01 cp 3x/j
2/ - Efferalgan 500mg cp _____ 01 bte
01 cp 3x/j

3/ - Vit-C cp 500mg _____ 01 bte
01 cp 2x/j matin et midi

ou Sargenor vit-c _____ 01 bte
01 Amp 2x/j matin et midi

⇒ éviter l'exposition prolongée sans soleil, repas
légers, boissons +++

⇒ Vaccin de sujet à risque

0,5 ml en sc en automne en dehors de H
infectieuse ou congestion ORL.

1/ - Paracétamol cp 500mg / sucr / sup _____ 01 bte
01 cp 3x/j 30 mg / kg / j

2/ - UPSA Vit-C - cp 01 cp 3x/j

3/ - Rhinathiel sup 01 càs 3x/j

4/ - Soufrane sol 02 pulv / Narine 3x/j

ou Souframycine sol 01 pulv / Narine 3x/j

(73)

* Rhume :

⇒ pas de fièvre, mal de gorge, toux modérée
Nz blanc hê ou coule dure : 10j

* Grippe :

- Biovex sach 01 sachet 2x 1j
- Dolipran cp 500 01 cp 3x 1j
- Vit C + Zinc cp 01 cp 1j
- Ebasca cp 10mg 01 cp 1j

(F4)

* Bronchite :

- pas de fièvre - Bronchite comme l'asthme sibilants enfant < 2 ans
 pas de fièvre, Rx Normal @ 3 épisodes
- il y a de la fièvre - Bronchite diffusants } 2 ans Rx Normal, Toux grasse
- fièvre grasse - pneumonie fièvre ↑ dyspnée Rx Amox crépitaux

Ordonnances :

1) - Clamoxyl 1g inj _____ QSP = 10j
 01 inj / j le matin

2) - Clamoxyl 1g gel _____ QSP = 10j
 01 gel / j le soir.

Si : allergie

1) - Zithromax 250mg cp _____ 01 ste
 2 cp / j en une seule prise en dehors repas
 puis 1 cp / j pdt 04j

3) - Diclofenac sup 100mg _____ 01 ste
 01 sup / j le soir pdt 6-7j

4) - Efferalgan 1000mg cp _____ 01 ste
 01 cp 4-5x / j

Si : Toux sèche → Euphon sup _____ 01 fl
 1 cà s 6x / j pdt 5-6j

Si : Toux sèche + éternuement et signes d'allergie
 Demoral sup _____ 01 fl
 01 cà s 4x / j (75)

Expectations à respecter (pas Antitumors)
 $S_0 =$ encaisser k $1812 =$

Sol = Encapsule 18g =
Flumucil 200mg sachet — 01 pc
01 sachet 3x 1j

- Bronchite aigue asthmatiforme :

1) - Augmentin cp 500mg / susp 125/250mg - 10g
 01 cp 2x1g 50mg/kg

2) - Fluimucil sachet $\times 3$ $\frac{1}{2}$

3) - Becotide spray 018/2

4) -Theophylline Lp cp $\frac{0.1 \text{ phul } 2 \times 1 \bar{j}}{0.1 \text{ cp } 2 \times 1 \bar{j}}$ ————— 0.1 Ye

* Aphites =

Aph' tus cp ————— 01/2/12

01 ср 3-4 ср

on Dakkarin gel 12 on tube

02 App 3x 15

+ Bicarbonate de soude sol bain de
boue 3x15

bonche $3 \times 10^{-}$

* Poussee dentaire = Delo dent

Debo dent

76

* Appendicite :

⇒ Douleur FID ou épigastrique vers FID, Nausée / Vomissements $37,5 - 38,5^{\circ}\text{C}$

examen : Douleur paroxysme à la palpation de FID
Défense parietale, douleur au TR.

⇒ FNS : Hyperleucos, stercorémie, iléus paralytique

Trt : Urgence chirurgicale

(H) + R -> Antibiotation + ATB paroxysme = occlusion

* Fissure anale :

1/ - Nitral plus _____ 024/3

01 app 3x / j

2/ - Diclufenac cp 75mg _____ 014/2

01 cp / j en milieu de repas

3/ - Zompéprazole gel 20mg _____ 014/2

01 gel / j

4/ - Forlax sac 1 sachet _____ 014/2

01 sachet 1 / j

* Dysurie :

1/ - Fluvermal sup 100mg _____ 01 flac

01 càc en seul prise 1 2 3 renouvelé

2/ - Vanileb sup _____ en 15 16 17

01 càc 3x / j

+ Hygiène des mains

8: Vomisse

(77)

* Intoxication alimentaire : on Hydrogne Adulte :

1) - Bactrim 200/400 _____ QSP: 07j
01 cp 3x1j

2) - Flagyl 500mg _____ QSP: 07j
01 cp 3x1j

3) - Dysentyl 200mg _____ 01 flc
02 cp 3x1j

4) - clomperane 10mg _____ 01 flc
01 cp 3 à 4x1j

5) - sparflox 1600 _____ 01 flc
01 cp 3x1j

⇒ Cocktail en perfusion = Eph
500mg flagyl + 01 Amp sparflox
+ 01 Amp prümperan si Vomité

Ordonnance :

1) - Flagyl cp 500mg _____ QSP: 07j
01 cp 3x1j

si Vomité + 2) - Vomité d 5mg _____ 01 flacon
01 càc 3x1j - 1h avant le repas

si Diarrhée 3) - Imodium cp _____ QSP: 102j
01 cp 3x1j



* Traumatisme thoracique =
 • Fracture costale 1^{er} & 2^e côtes

1) - Elastoplast _____ N° = 05

2) - Doliprane cp 1g _____ 01 sup 1j
 01 cp 3x1j

3) - Voltarene cp 75mg _____ 01 sup 1j
 01 cp 3x1j

4) - Zimac gel 20mg _____ 01 sup 1j
 01 gel 2x1j

• Affection musculo-squelettique =

1) - Kifenex patch _____ 01 sup 1j
 01 patch 2x1j

2) - Doliprane cp 1g _____ 01 sup 1j
 01 cp 3x1j

3) - 3 côtes ⇒ Admission surveillance

* Plaie par arme blanche =

1) - Oxacilline cp 500mg _____ 01 cp 3x1j

2) - Niflural sup 750mg _____ 01 sup 1j

3) - Zimac gel 20mg _____ 01 gel 2x1j

4) - Codolipran cp _____ 01 cp 3x1j

* Chute haut =

Coste droit = Rx Thorax

" gauche = échographie

* Constipație :

1. - Duphalac sup 01 căc 02x/j.
- Glycérine suppo 1-2 suppo/j.
- Ezilax (Lactulose) sup 01 căm 01x/j.
- Forlax sachet 040mg (E) 01 sachet
- 10mg (A) 03x/j.

(Debrüdat)

- Trimebutine cp 01cp 02x/j.
- Duphalac sachet 01 sachet 3x/j.
- Bedelix sachet 01 sachet 3x/j.
- Debrüdat cp 100mg 01cp 3x/j.
- Huile de parafine 01 căm 2x/j.
- Sparfon lyoc 01 lyoc 3x/j.
- 01 vâlcuș d'EAU MATIN
- 01 căc huile d'olive se sear

* Vomissements :

- Domperidone cp 01cp 2-3/j 15 min avant R
- Prémperan cp 5mg
- CI si = epilepsie / parkinson
- Vogalène gel 15mg 01gel 1-2x/j

(80)

* Abcès périanal :

1) - flucloxacil cp 500mg _____ φ SP = 10g
 olcp 3x 1g

2) - Oxacilline cp 500mg _____ φ SP = 10g
 olcp 2x 1g

3) - Voltarène cp 75mg _____ ol4te
 olcp 1g

4) - Zénac gel 50mg _____ ol4te
 olgel 1g

5) - Permanganate de K⁺ _____ ol4te
 olcp diluée ds 5l d'eau tiède puis choyer et biberonner

* Abcès _____ anal :

* Abcès anal :

Non collectés

Ceface K cp 1g _____ φ SP = 10g
 olcp 3x 1g

Dolipran 1g cp _____ ol4te
 olcp 3x 1g

Collec _____ té : Drainage

* Plaie infectée :

- ceface K cp 1g 1cp 3x 1g φ SP = 10g
 - profim d cp 100mg 1cp 2x 1g

81

Amox ou
 Dolipran =

* RGO :

- Gaviscan Sachet / suşu _____ 01 ste
01 sachet 3x1j
- Mulex suşu _____ 01 ste
01 cam 3x1j
- Azenkac cp 300mg _____ 01 cp 1j } QSP :
- Omeprazole (IPP) 10/20mg - 1 gel 1j } 01 mois

* Ulcere gastro - duodénale :

- Loméprazole gel 20mg _____ QSP : 01 mois
01 gel 2x1j pdt 7j avant
01 gel 1j pdt 21j & 1 rep
- Amoxicilline gel 500mg _____ QSP : 10j
02 gel 2x1j hors les repas -

* Pancréatite :

- Cefaclor 1g 4x1j - sparfloxacin 01mg 3x1j
- Flacyl 500mg 3x1j - Azenkac 01mg 1j
- pefalgan 1g 4x1j - clafuran 01g 3x1j

* Occlusion :

ASP / TDM

* Cholecystite aiguë :

⇒ Admission + Trt ATB

- Ceface 1g 3x1j } en IVL
- Flagyl 500mg 3x1j }

+ Antalgique = parafolgan 1g 3x1j

+ Antispasmodique = Spasfon 2Amp 3x1j

+ Réhydratation = 1500 cc SSI
1500 cc SGI

* Angiocholite :

⇒ Admission + Trt identique au cholecystite

* Appendicite :

⇒ Admission + Trt identique sauf ATB

* Péritonite :

⇒ Admission + Trt standard + chirURGIE

* Aérocolie :

1 - Métréoxone gel _____ o15te

o1ge 3x1j

2 - Daburidat _____ o15te

o1cà 3x1j

* Leishmaniose Cutanée.

- lésion multiple : Glucantime IM profonde.
- lésion unique sur uv face : Glucantime IM
- 1 unique aux MI : infiltrations cutanées
0.2 cc 2x/sem pdr 04 semaines

* Glucantime en IM profonde :

• **enfant** : Dose en cc = $\frac{4 \times \text{poids} \times 20}{100}$

le 1^{er} j = 1/4 dose 425

le 2^{ème} j = 1/2 dose

le 3^{ème} j = 3/4 dose

le 4^{ème} j = Dose complète pdr 10j

• **Adulte** :

1^{er} j = 1cc / IM

2^{ème} j = 2cc / IM

3^{ème} j = 3cc / IM

4^{ème} j = 4cc / IM pdr 10j

CI = insuff rénals, insuff hépat, Cardiopathie
NRS < 2ans.

il faut = ECG + TLT

bilan = FNS / TP / bilan rénal
et hépatique.

* Bouchon du Cerumen

- 1) - H_2O_2 solu = eau oxygénée
nettoyage 3x1j
- 2) - Outilyse 2,5g / 100ml solut } 05j
2x1j

après 5ème j $\Rightarrow$ extraction du Bouchon
de un OHL.

ou Cerulysse gtt ———— 01 flacon.
02 gtt 3x1j pdr 00j.

* Otite:

• otite externe: Douleur lors de traction du pavillon
ou l'appui sur tragus

• otite moyenne: y a des vertiges, tympan bouché

1) - Otocine dextre 01 dose 2x1j 05le 8j

2) - Otiprane cp 1g 01cp 2x1j

1) - Otofa gtt 01 gtt 2x1j 05p 05j

Otocine chez enfant > 2 ans.

faut

* Herpes cicaté:

Varo crème 01 App 2x1j pdr 20j

Betacyl pmd 01 App 1j pdr 15j

Ketocanazole 01 App 2x1j

(85)

* Embolie Pulmonaire :

- Clinique : Syncope - Lipothymie
Tachycardie > 100 , douleur angineuse
par le paradoxe, cyanose.
- ⇒ état de choc : marbrures, collapsus
- ⇒ Trouble de Repolarisation : T, V₁-V₃, BBL
- ⇒ Hypoxie sévère $PaO_2 < 60\%$, acidose

* CAT :

* O₂ fort débit

* Remplissage Vasopresseurs : Dobutrex,
NorAdrénaline

* HNF 500 UI/kg/j en PSE avec TCA à
H₄ objectif : 2-3.

* Thrombolyse : si EP + état de choc

* Re-lais AVK + anti-X à J₄ avec
surveillance : TCA, fibrinogène, p_a
si échec : embolectomie chirurgicale

* Clinique : Probabilité faible ou moyenne
Dosage D-D si (+) ⇒ AngioScanner.
si doute : éliminer TVP + Scintigraphie

Probabilité forte $\Rightarrow$ Angioscanner si (-) $\Rightarrow$
échodoppler

$\Rightarrow$ Position demi-assise, O_2 & SpO_2 $> 95\%$
WP (bilan Hémobase avant anticoagulation)
HBPM en s/c immob 175 UI/Kg en 1 inj / j
ou Lovenox 100 UI/Kg 2x/j

OAP $\Rightarrow$ râles crépitants, orthopnée, dyspnée
Radio: râle de papillon
pas douleur, Notion d'HVA ou Cardiopath

EP $\Rightarrow$ TVP / immobilité / grossesse / Né
Rx: Na... D-Dimères positifs (+)
douleur banthracique, hémoptysie

IDM $\Rightarrow$ Douleur constrictrice, ECG et troponine
(+)